

«Накладання оклюзійної пов'язки»

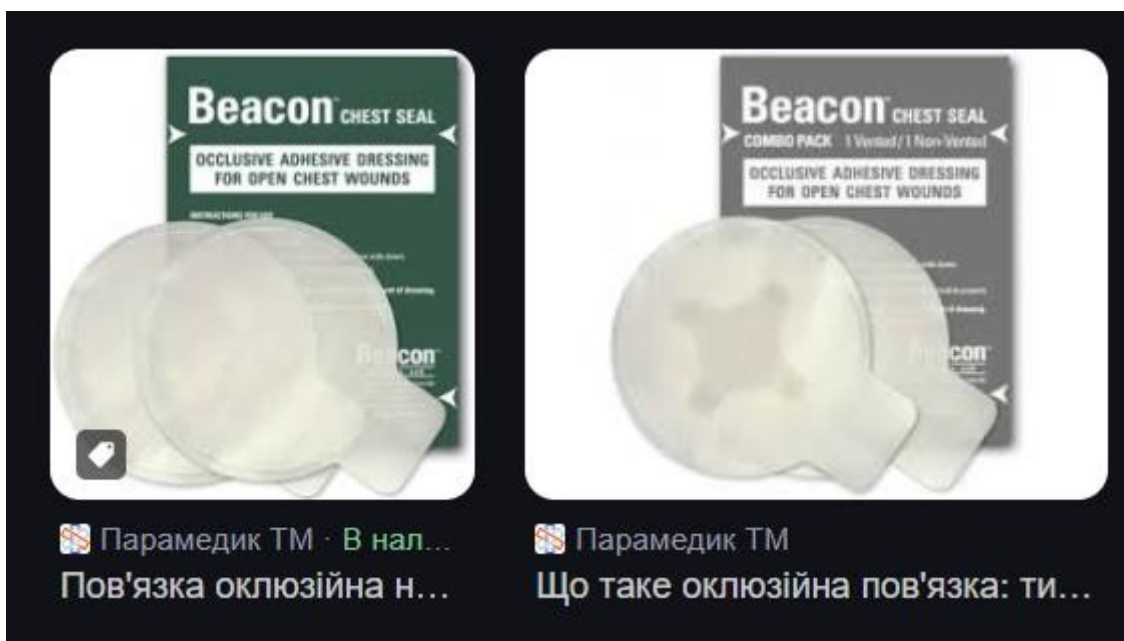
перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

Сценарій. До приймального відділення доставлено постраждалого з проникаючим колотим пораненням грудної клітки ліворуч. Діагностовано лівобічний відкритий пневмоторакс. Треба провести накладання оклюзійної пов'язки при відкритому пневмотораксі.

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Оклюзійна пов'язка 20х30 мм	1 шт.
2	Хірургічний пінцет	1 шт.
3	Хірургічний лоток	2 шт

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Шприц 10 мл	2 шт	20 шт
4	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
5	Асептична пов'язка	1 шт	10 шт
6	Захисна медична маска	1 шт	10 шт



№ *Маніпуляція* Форма
представлен

1	Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль) Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій Сказати

3	Обробка рук антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Обрати необхідну пов'язку	Виконати

5	Шкіру навколо рани обробити антисептиком	Сказати
6	Накласти герметичну частину пов'язки (стерильною стороною прогумованої оболонки пов'язкою щільно закривають рану грудної стінки з виступом за краї на 4 – 5 см. Краї оболонки повинні герметично пристати до шкірі)	Сказати и/ Виконати
7	Накласти пов'язку повністю: (накласти обидві подушечки пакета стороною, не прошитою кольоровою ниткою, на прогумовану оболонку)	Виконати
8	Фіксувати пов'язку	Виконати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка правильності накладання пов'язки

Говорити: «Пов'язка накладена герметично. Непроникний матеріал перекриває ватно-марлеві подушечки з виступом на 4–5 см за їх краї. Матеріал щільно прилягає до шкіри, фіксований циркулярною пов'язкою до грудної клітки.»

3.2. Оцінка ефективності накладання пов'язки

Говорити: «Після накладання пов'язки динаміка пацієнта стабільна. Не відмічається ознак прогресування дихальної недостатності або зростання підшкірної емфіземи.

Пов'язка виконує функцію запобігання потраплянню повітря в плевральну порожнину.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Необхідність додаткових методів дослідження

Говорити: «Для підтвердження діагнозу та оцінки ступеня ураження рекомендовано провести рентгенографію органів грудної клітки у двох проекціях або КТ органів грудної клітки.»

4.2. Подальша лікувальна тактика

Говорити: «Пацієнт підлягає госпіталізації у відділення хірургії або торакальної хірургії. Показано накладання герметичної оклюзійної пов'язки, дренирування плевральної порожнини по Бюлау за показаннями, контрольна рентгенографія

після маніпуляції. Знеболення, оксигенотерапія та інфузійна підтримка за потреби.»

5. Після завершення маніпуляції

Говорити та робити: «Умовно утилізую використаний матеріал, знімаю рукавички, обробляю руки антисептиком.»

Маніпуляцію завершено